

Hipertensão arterial · crise e crônica

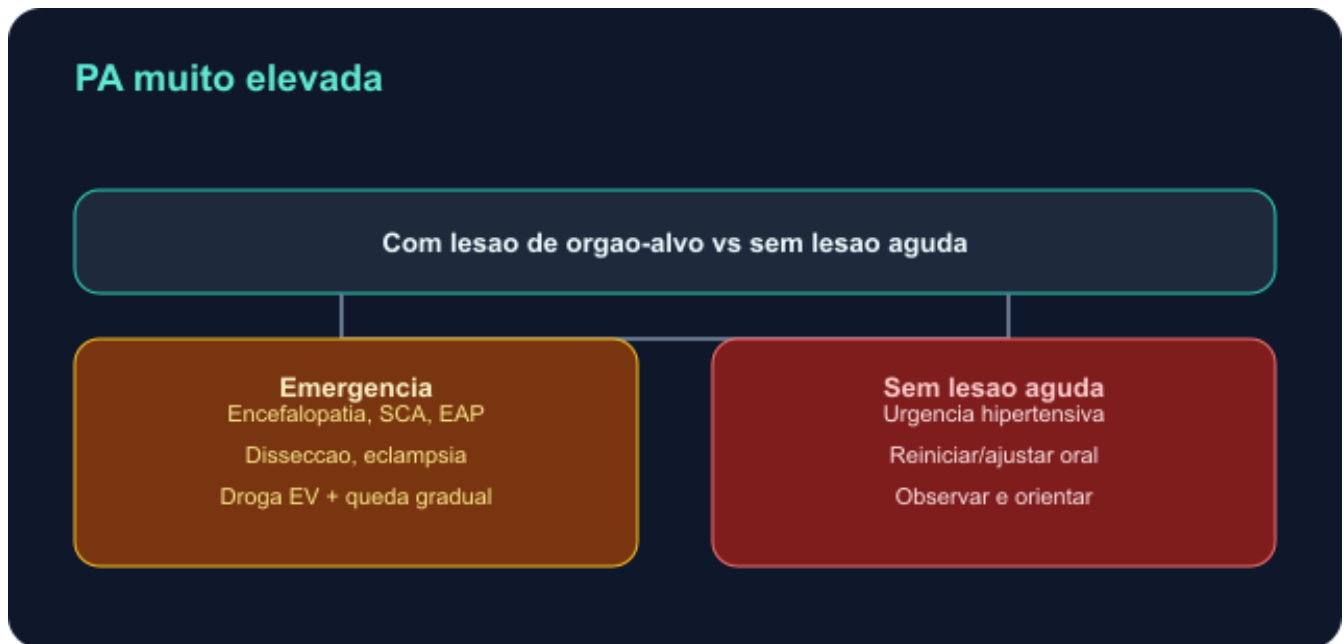
Separe HAS crônica (adesão e combinação) de emergência hipertensiva (lesão de órgão-alvo aguda). Na emergência, reduza PA de forma controlada — não 'normalize' em minutos.

Combinação inicial

Dica - Combinação inicial

Em estágios mais altos ou risco CV, prefira associação (IECA/BRA + BCC ou tiazídico). Monoterapia raramente basta quando PA está muito acima da meta.

Ramificação: lesão aguda = emergência (EV, UTI); sem lesão = urgência/ajuste oral e investigação.



Pontos de conduta crônica

- Confirmar com MAPA/MRPA quando dúvida diagnóstica ou efeito do avental branco
- IECA/BRA: preferir em DM, proteinúria, IC; monitorar creatinina e K z
- Betabloqueador: não é 1ª linha isolada salvo pós-IAM, FA, IC
- Investigar secundária se início jovem, resistente, hipoK, sopro ou piora abrupta

Emergência — exemplos de droga

Cenário | Preferência clássica

EAP hipertensivo | Nitroglicerina / nitroprussiato

SCA | Nitrato + betabloqueador se apto

Dissecção de aorta | Betabloqueador primeiro, depois vasodilatador

Encefalopatia hipertensiva | Nitroprussiato / nicardipino (queda controlada)

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não use nifedipina sublingual de 'rescate' na emergência hipertensiva — queda imprevisível e risco isquêmico. Evite reduzir PA >25% na 1ª hora (exceto dissecação/eclampsia, com metas específicas).

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Estadiamento da PA e a distinção emergência × urgência hipertensiva mudam a velocidade e a via de redução pressórica.

Estádios de PA (SBC ideia)

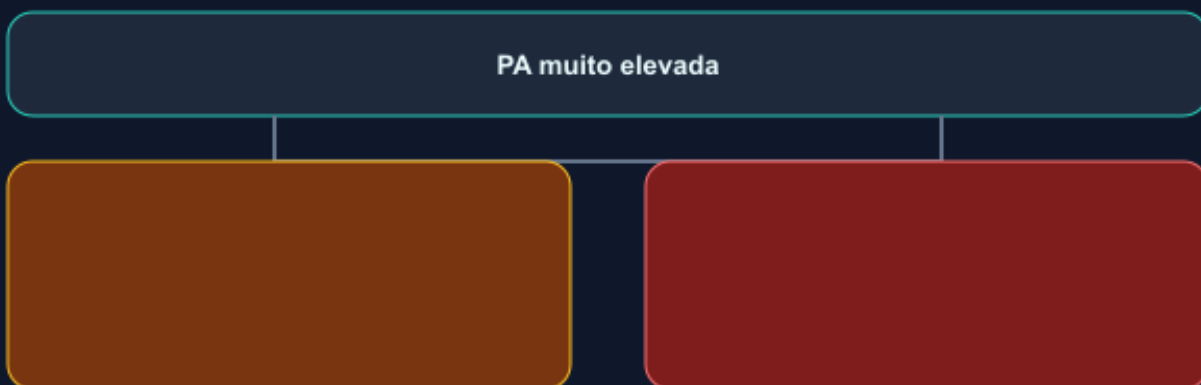
Consultório

Normal: < 120/80	N
Pre-HAS: 120-139 / 80-89	P
HAS 1: 140-159 / 90-99	1
HAS 2: 160-179 / 100-109	2
HAS 3: >= 180 / >= 110	3

Diagnostico com medias repetidas / MAPA/MRPA quando duvida

Emergência = lesão aguda de órgão-alvo !' reduzir PA em minutos–horas com droga IV.

Urgencia vs emergencia



Metas de redução na emergência (ideia)

Cenário | Meta

Maioria das emergências | reduzir PAM ~20–25% na 1ª hora

Dissecção aórtica | PAS < 120 rapidamente (beta !' vasodilatador)

AVC isquêmico pós-trombólise | ver metas específicas (<185/110 pré)

Urgência hipertensiva | redução gradual VO em 24–48 h

Lesão de órgão-alvo aguda

- Neuro: encefalopatia hipertensiva, AVC hemorrágico, papiledema
- Cardio: SCA, edema agudo de pulmão, dissecção aórtica
- Renal: LRA aguda com hematúria/proteinúria marcante
- Gestação: pré-eclâmpsia grave / eclâmpsia

Não faça

Atencao - Não faça

Evitar queda abrupta excessiva de PA na urgência (risco de isquemia cerebral/renal/coronária).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1